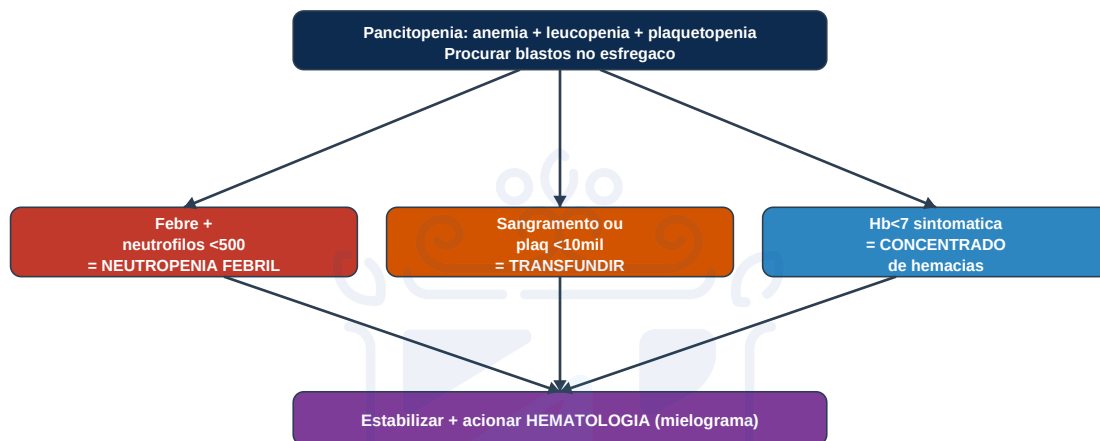


PANCITOPENIA NO PS — EMERGÊNCIA E CAUSA

FLUXOGRAMA — PRIORIDADES NO PS

PANCITOPENIA — IDENTIFICAR A EMERGÊNCIA



DEFINIÇÃO

O QUE É

- Redução **SIMULTÂNEA** das 3 linhagens: hemácias (anemia) + leucócitos (leucopenia) + plaquetas (plaquetopenia)
- **NÃO** é diagnóstico — é achado laboratorial de múltiplas causas
- Principais riscos: sepse (neutropenia), sangramento (plaquetopenia), anemia sintomática
- Diagnóstico definitivo: mielograma / biópsia de medula óssea (**NÃO** no PS)

CAUSAS PRINCIPAIS

Mecanismo	Exemplos	Pista clínica
Falência/infiltração medular	Aplásica, leucemia aguda, mielodisplasia, metástase	Blastos, sintomas B, organomegalia
Carência	Déficit de B12 / folato (megaloblástica)	Macrocitose, glossite, álcool
Hiperesplenismo	Cirrose, esquistossomose	Esplenomegalia, estigmas hepáticos
Drogas mielotóxicas	QT, metotrexato, carbamazepina	História medicamentosa
Infecção	HIV, hepatites, parvovírus B19, CMV, EBV	Sorologias, contexto epidemiológico
Autoimune	LES, artrite reumatoide	FAN, clínica de doença de base

PERGUNTAS-CHAVE

ANAMNESE DIRIGIDA

- Há quanto tempo os sintomas (fadiga, febre, sangramentos)?
- Tem febre agora? Infecções de repetição?
- Está sangrando? Roxos na pele, gengivorragia?
- Usa medicamentos? Quimioterapia, anticonvulsivantes, antibióticos?
- Etilismo? HIV / hepatite? Doença autoimune (lúpus, AR)?

EXAMES — PS

SOLICITAR

- Hemograma com diferencial: avaliar VCM, reticulócitos e PRESENÇA DE BLASTOS
- Função renal e hepática (TGO, TGP, BT, albumina) + LDH e BI (hemólise/lise)
- Coagulograma (TP, TTPA)
- Vitamina B12 e ácido fólico; sorologias HIV, hepatites B e C
- Se febre: hemoculturas (2 pares), urocultura, RX tórax, PCR/procalcitonina
- Conforme suspeita: FAN/anti-DNA (LES), TSH, TC crânio (se cefaleia/sangramento)

TRATAMENTO — A) NEUTROPENIA FEBRIL (EMERGÊNCIA)

Rx FEBRE + NEUTRÓFILOS < 500/mm³

Definição: febre $\geq 38,3$ C (ou 38 C por > 1 h) + neutrófilos $< 500/\text{mm}^3$
Hemoculturas (2 pares) ANTES do antibiótico — sem atrasar a 1a dose
ATB amplo espectro IMEDIATO (< 1 h): Piperacilina-tazobactam 4,5g IV 6/6h
OU Cefepime 2g IV 8/8h OU Meropenem 1g IV 8/8h (se instável/resistência)
Se instabilidade ou suspeita MRSA/cateter: adicionar Vancomicina 15-20 mg/kg IV 12/12h
Hidratação venosa + suporte; internação em UTI/semi + acionar hematologia

TRATAMENTO — B) SANGRAMENTO / C) ANEMIA GRAVE

Rx PLAQUETOPENIA / SANGRAMENTO

Plaquetas < 10.000 : transfundir profilaticamente
(1 aférese ou 6-8 U de pool)
Sangramento ativo: transfundir independente do valor
(meta > 50.000 se sangramento ativo)
Evitar IM, punção arterial, AINE, AAS
Sangramento grave: ác. tranexâmico 1g IV 8/8h

Rx ANEMIA GRAVE SINTOMÁTICA

Hb < 7 : transfundir concentrado de hemácias
Hb 7-8 com sintomas (dispneia, angina, taquicardia):
transfundir
Cardiopata/idoso: considerar com Hb < 8
Transfundir lentamente (evitar sobrecarga)
Furosemida 20-40mg IV entre bolsas se cardiopatia

CENÁRIOS ESPECIAIS

D) BLASTOS / E) MEGALOBLÁSTICA

- BLASTOS no hemograma = suspeita de leucemia aguda: NÃO iniciar QT no PS
- Acionar hematologia URGENTE; suporte + hidratação + Alopurinol 300mg/dia (profilaxia de lise)
- B12 < 200 pg/mL: B12 1000 mcg IM/dia por 7 dias, depois semanal por 4 semanas
- + Ácido fólico 5mg VO/dia
- NUNCA repor folato isolado sem B12 — piora a neuropatia

CRITÉRIOS DE INTERNAÇÃO

INTERNAR SE

- Neutropenia febril (neutrófilos < 500 + febre)
- Sepses / choque séptico
- Plaquetas < 10.000 ou sangramento ativo
- Anemia grave sintomática (Hb < 7 , ou < 8 com sintomas)
- Suspeita de leucemia aguda (blastos) ou necessidade de suporte transfusional

CHECKLIST DE ALTA

ALTA SE (pancitopenia leve/moderada assintomática)

- ☐ Neutrófilos > 1000 , plaquetas > 20.000 , Hb > 8 sem sintomas
- ☐ Sem febre, sangramento ou instabilidade
- ☐ Encaminhamento garantido para hematologia (< 7 dias)
- ☐ Evitar AINE/AAS, aglomerações, alimentos crus, trauma; escova macia, sem lâmina de barbear
- ☐ Retorno IMEDIATO se febre, sangramento ou fraqueza extrema

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA HEMATOLOGIA

- Pancitopenia: Hb ___, leucócitos ___, neutrófilos ___, plaquetas ___.
- Sintomas: ___ | Exame: ___ (palidez/petéquias/organomegalia). Blastos: presentes/ausentes.
- Sem sepse/sangramento ativo no momento; fatores de risco: ___.
- Exames iniciais realizados (função renal/hepática, LDH, B12, folato, sorologias).
- Solicito avaliação hematológica URGENTE (mielograma/biópsia) e definição de conduta.

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente em quimioterapia, febre 38,8 C, neutrófilos 320/mm³. Qual a conduta prioritária?

- A) Aguardar resultado das hemoculturas antes de iniciar antibiótico
- B) Antipirético e reavaliação em 24h
- C) Coletar hemoculturas e iniciar antibiótico de amplo espectro em até 1 hora
- D) Transfundir plaquetas profilaticamente
- E) Iniciar fator estimulador de colônias isoladamente

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Homem etilista com pancitopenia, VCM 112, glossite. B12 sérica baixa. Qual erro pode agravar o quadro neurológico?

- A) Repor B12 intramuscular
- B) Repor folato isoladamente sem reposição de B12
- C) Solicitar reticulócitos
- D) Investigar mielodisplasia
- E) Suspende o álcool

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Paciente com pancitopenia e plaquetas 6.000/mm³, sem sangramento. Conduta?

- A) Não transfundir até surgir sangramento
- B) Transfundir plaquetas profilaticamente (< 10.000)
- C) Transfundir somente se plaquetas < 5.000
- D) Iniciar ácido tranexâmico e dispensar transfusão
- E) Corticoide em altas doses

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Hemograma com pancitopenia e 30% de blastos circulantes. Qual a conduta no PS?

- A) Iniciar quimioterapia de indução imediatamente no PS
- B) Alta com retorno ambulatorial em 30 dias
- C) Suporte (transfusão/ATB se febre), hidratação + alopurinol e acionar hematologia urgente
- D) Apenas transfusão de hemácias e alta
- E) Corticoide e observação domiciliar

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Qual exame é definitivo para esclarecer a causa de uma pancitopenia, mas NÃO deve ser realizado no PS?

- A) Reticulócitos
- B) Mielograma / biópsia de medula óssea
- C) LDH
- D) Eletroforese de hemoglobina
- E) Dosagem de ferritina

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

Neutropenia febril é emergência oncológica: hemoculturas (2 pares) sem atrasar e ATB empírico amplo (Pipe-tazo/Cefepime/Meropenem) em < 1h. Atrasar antibiótico aumenta mortalidade. Não se aguarda cultura para iniciar.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Folato isolado em deficiência de B12 corrige a anemia mas pode precipitar/piorar a degeneração neurológica (mielose funicular). Sempre repor B12 junto, e na dúvida iniciar B12 antes ou em conjunto.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Gatilho de transfusão profilática de plaquetas é < 10.000/mm³ mesmo sem sangramento, pelo risco de sangramento espontâneo (incl. SNC). Com sangramento ativo, transfunde independente do número (meta > 50.000).

QUESTÃO 4 → Resposta: C

Blastos = suspeita de leucemia aguda. No PS: NÃO iniciar QT; dar suporte (transfusão/ATB se febre), hidratar e iniciar alopurinol para profilaxia de síndrome de lise tumoral, e acionar hematologia com urgência.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

O diagnóstico etiológico definitivo da pancitopenia é o mielograma/biópsia de medula, conduzido pela hematologia — não é exame de PS. No PS prioriza-se estabilizar e tratar as emergências.

SM24
Suporte ao Plantão Médico